PCOD Xpert

Hope Blooms from Within

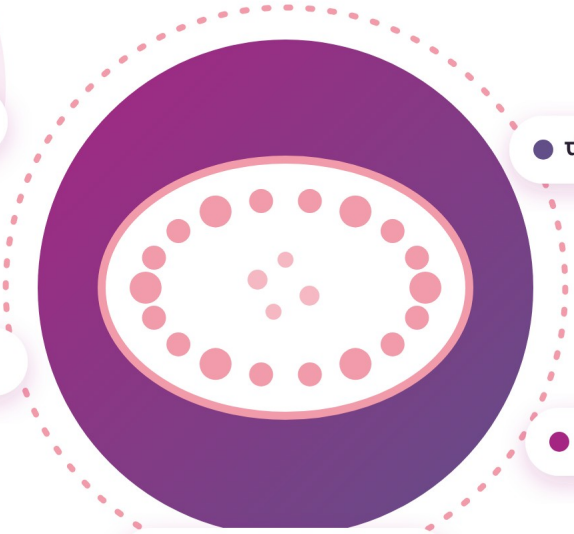
रोगी मार्गदर्शिका

PCOS का नया नाम: PMOS

सब कुछ जानिए

PCOD और PMOS

महिलाओं, किशोरियों और परिवारों के लिए एक
सरल, चित्रों वाली गाइड



Hope Blooms from Within

यहाँ से शुरू करें

स्वागत है

अगर आपको बताया गया है कि आपको **PCOD या PCOS** है, तो आप अकेली नहीं हैं। प्रजनन आयु की लगभग **हर 5 में से 1** महिला को यह होता है। यह आम है, इसे संभाला जा सकता है, और इसे समझना पहला कदम है।

इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें

- एक बार में एक पेज पढ़ें। हर पेज एक चित्र के साथ एक बात समझाता है।
- **लक्षण डिकोडर** (पेज 14) से समझें कि आपका शरीर क्या बता रहा है।
- **ट्रैकर** (पेज 26) भरें और अपॉइंटमेंट पर साथ लाएँ।

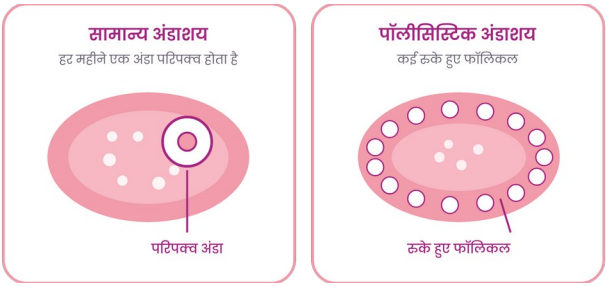
किशोरियों और माता-पिता के लिए

पहले पीरियड के बाद के 2 से 3 साल में अनियमित पीरियड्स आम हैं। डॉक्टर देख सकते हैं कि शरीर अभी बस सेट हो रहा है, या इलाज की ज़रूरत है।

इस पुस्तिका में

3	PCOM, PCOD, PCOS, PMOS क्या हैं?	4	स्पेक्ट्रम और नया नाम
5	आपका मासिक चक्र	6	हार्मोन
7	यह क्यों होता है	8	ध्यान देने योग्य लक्षण
9	पीरियड्स: सामान्य या नहीं?	10	बाल, मुँहासे और बाल झड़ना
11	इंसुलिन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम	12	फर्टिलिटी और गर्भावस्था
13	जाँच कैसे होती है	14	लक्षण डिकोडर
15	सही खान-पान	16	आपका 5-चरण आहार रोडमैप
17	चलें, सोएँ, शांत रहें	18	इलाज के विकल्प
19	इलाज: पीरियड, त्वचा, बाल	20	इलाज: वज़न, नींद, गर्भाशय
21	मन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य	22	हमारी PCOD Xpert टीम
23	3 और 6 महीने के प्रोग्राम	24	मिथक और तथ्य
25	सवाल और जवाब	26	मेरा ट्रैकर
27	मरीज़ों की कहानियाँ	28	संपर्क करें

PCOM, PCOD, PCOS और PMOS क्या हैं?



आपके अंडाशय (ओवरी) में अंडे छोटी, तरल भरी थैलियों में रहते हैं जिन्हें **फॉलिकल** कहते हैं। हर महीने आमतौर पर एक फॉलिकल बढ़ता है, परिपक्व होता है और अंडा छोड़ता है। इस परिवार की स्थितियों में कई फॉलिकल बढ़ना शुरू करते हैं पर **रुक जाते हैं**, इसलिए अंडा समय पर नहीं निकलता।

ये "सिस्ट" नहीं हैं जिन्हें निकालना पड़े

स्कैन में दिखने वाले छोटे बिंदु रुके हुए फॉलिकल हैं, हानिकारक सिस्ट नहीं। ये कैंसर में नहीं बदलते और आमतौर पर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती।

आपने ये चार नाम सुने होंगे

PCOM	पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। सिर्फ़ स्कैन में छोटे फॉलिकल दिखते हैं।
PCOD	पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। हल्का हार्मोन और कोशिकीय असंतुलन।
PCOS	पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पूरे शरीर की हार्मोन और मेटाबॉलिक स्थिति।
PMOS	पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। PCOS का नया आधिकारिक नाम।

जानना ज़रूरी है

- **यह आपकी गलती नहीं है।** जीन, हार्मोन और इंसुलिन की भूमिका होती है।
- **इसे संभाला जा सकता है।** सही देखभाल से ज़्यादातर लक्षण सुधरते हैं।

नया नाम

स्पेक्ट्रम और नया नाम

डॉक्टर अब इन्हें **एक स्पेक्ट्रम की सीढ़ियाँ** मानते हैं। आप कहाँ हैं, यह आपके इतिहास, जाँचों और स्कैन के बाद डॉक्टर तय करते हैं।



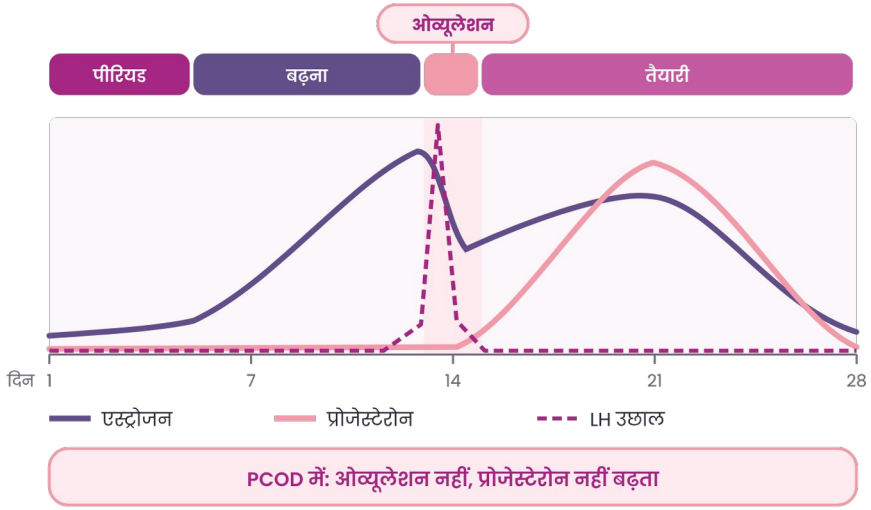
नाम	इसका मतलब	आम योजना
PCOM	सिर्फ़ स्कैन में छोटे फॉलिकल दिखते हैं। हार्मोन की समस्या नहीं। पीरियड नियमित, गर्भधारण आसान, कोई लक्षण नहीं।	**1 से 2 महीने की लक्षित डाइट**
PCOD	हल्का हार्मोन और कोशिकीय असंतुलन। अंडाशय की दो कोशिकाओं के बीच संकेत गड़बड़ाने से अपरिपक्व अंडे निकल सकते हैं। अनियमित पीरियड, वज़न बढ़ना, मुँहासे।	**3 से 4 महीने: लक्षित डाइट, गतिविधि, जीवनशैली में बदलाव और कुछ दवाएँ**
PCOS	ज़्यादा जटिल, पूरे शरीर की हार्मोन और मेटाबॉलिक स्थिति। ज़्यादा एंड्रोजन ओव्यूलेशन बिगाड़ते हैं; इंसुलिन रेज़िस्टेंस, डायबिटीज़, हृदय रोग का जोखिम बढ़ता है।	**3 से 6 महीने की व्यवस्थित योजना, फिर नियमित समीक्षा**
PMOS	PCOS का नया आधिकारिक नाम। यह नाम बताता है कि यह सिर्फ़ अंडाशय की नहीं, पूरे शरीर की हार्मोन और मेटाबॉलिक स्थिति है।	**PCOS जैसी ही देखभाल**

PCOS का नाम PMOS क्यों हुआ

पुराना नाम सुनकर लगता था कि यह अंडाशय में "सिस्ट" की समस्या है। असल में इसमें इंसुलिन, कई हार्मोन और **पूरे शरीर** का मेटाबॉलिज़्म शामिल है। **PMOS** PCOS का नया आधिकारिक नाम है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थाओं और विशेषज्ञ समूहों की सहमति है।

आपका मासिक चक्र

सामान्य चक्र आपके मस्तिष्क, अंडाशय और गर्भाशय के बीच **हार्मोन का नृत्य** है। दिन 1 यानी ब्लीडिंग का पहला दिन।



पीरियड
दिन 1-5
गर्भाशय की परत ब्लीडिंग के रूप में निकलती है।

बढ़ना
दिन 1-13
अंडे की थैलियाँ बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन बढ़कर परत बनाता है।

ओव्यूलेशन
लगभग दिन 14
LH का उछाल अंडा छोड़ता है।

तैयारी
दिन 15-28
प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को तैयार करता है। गर्भ नहीं ठहरा तो पीरियड आता है।

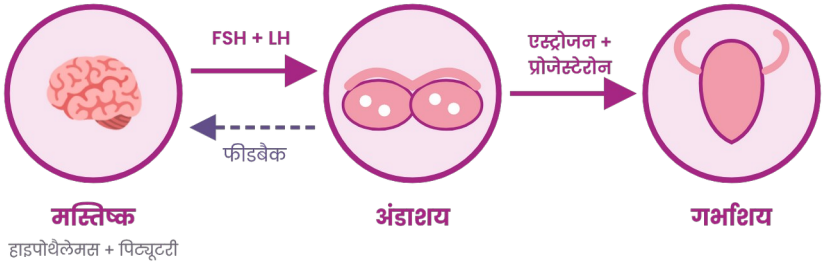
PCOD में क्या बदलता है?

अंडा अक्सर **निकलता ही नहीं**। ओव्यूलेशन के बिना प्रोजेस्टेरोन नहीं बढ़ता, इसलिए पीरियड्स **देर से, छूटे हुए या भारी** हो जाते हैं और गर्भधारण में समय लगता है।

आपका शरीर

हार्मोन

हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक हैं। मस्तिष्क अंडाशय को संदेश भेजता है और अंडाशय वापस संदेश भेजते हैं। PCOD में यह बातचीत असंतुलित हो जाती है।



FSH
हर महीने अंडे की थैली को बढ़ाता है।

LH
अंडा निकलने का संकेत देता है। PCOD में अक्सर ज़्यादा।

एस्ट्रोजन
गर्भाशय की परत बनाता है। त्वचा और हड्डियों के लिए ज़रूरी।

प्रोजेस्टेरोन
ओव्यूलेशन के बाद गर्भाशय तैयार करता है। PCOD में कम।

एंड्रोजन
हर महिला में थोड़े बनते हैं। PCOD में ज़्यादा: मुँहासे, बाल।

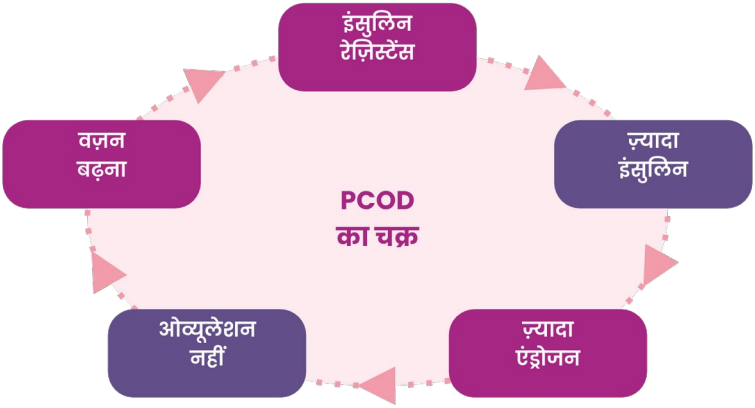
इंसुलिन
शुगर को कोशिकाओं में पहुँचाता है। PCOD में अक्सर ज़्यादा।

थायरॉइड और प्रोलैक्टिन की गड़बड़ी भी PCOD जैसी लग सकती है। इसलिए हम इनकी जाँच भी हमेशा करते हैं।

कारण

PCOD क्यों होता है?

इसका कोई एक कारण नहीं है। कई बातें मिलकर एक-दूसरे को बढ़ाती हैं, एक चक्र की तरह।



क्या-क्या जुड़ता है

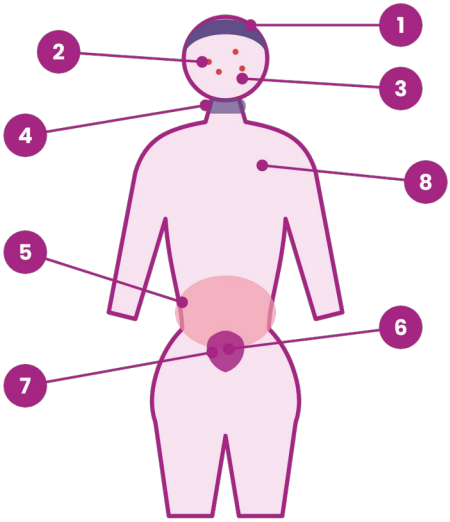
- **पारिवारिक इतिहास:** माँ, बहन या मौसी को PCOD या डायबिटीज़।
- **इंसुलिन रेज़िस्टेंस:** कोशिकाएँ इंसुलिन पर कम प्रतिक्रिया देती हैं।
- **अतिरिक्त एंड्रोजन:** अंडाशय और एड्रिनल ग्रंथि ज़्यादा बनाती हैं।
- **हल्की सूजन** (इन्फ्लेमेशन) इंसुलिन रेज़िस्टेंस को बनाए रखती है।
- **जीवनशैली:** कम गतिविधि, कम नींद, तनाव और बढ़ा वज़न इसे बिगाड़ सकते हैं।

अच्छी खबर

आप इस चक्र को **किसी भी जगह** तोड़ सकती हैं। अगर वज़न ज़्यादा है, तो शरीर के वज़न का सिर्फ **5 से 10%** घटाने से भी नियमित ओव्यूलेशन और पीरियड्स लौट सकते हैं।

ध्यान देने योग्य लक्षण

हो सकता है आपको इनमें से कुछ ही हों। हर महिला अलग होती है। नंबर चित्र से मिलाएँ।



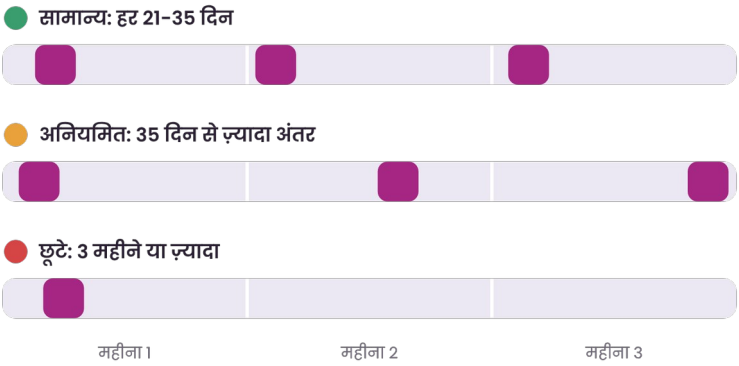
1	माँग (पार्टिंग) पर बाल पतले होना	2	मुँहासे और तैलीय त्वचा
3	ठुड्डी, ऊपरी होंठ पर ज़्यादा गहरे बाल	4	गर्दन, बगल में गहरे, मखमली दाग
5	वज़न बढ़ना, खासकर पेट के आसपास	6	अनियमित, छूटे या भारी पीरियड्स
7	गर्भधारण में कठिनाई	8	उदासी, चिंता, थकान, कम नींद

अगर इनमें से **दो या ज़्यादा** दिखें, या कोई एक परेशान कर रहा हो, तो डॉक्टर से मिलें।

लक्षण

पीरियड्स: सामान्य या नहीं?

पीरियड्स आपके हार्मोन का मासिक रिपोर्ट कार्ड हैं। इसे ऐसे पढ़ें।



सामान्य	हर **21 से 35 दिन** में पीरियड। ब्लीडिंग **2 से 7 दिन**। पैड 3 से 4 घंटे या उससे कम बार बदलना।
जाँच करवाएँ	चक्र **35 दिन से लंबा**, साल में 8 से कम पीरियड, महीने छूटना, बीच में स्पॉटिंग।
जल्दी डॉक्टर से मिलें	**3 महीने से पीरियड नहीं** (गर्भ भी नहीं)। 2 घंटे तक हर घंटे पैड भीगना। बड़े थक्के। 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग। तेज़ दर्द।

छूटे पीरियड्स क्यों मायने रखते हैं

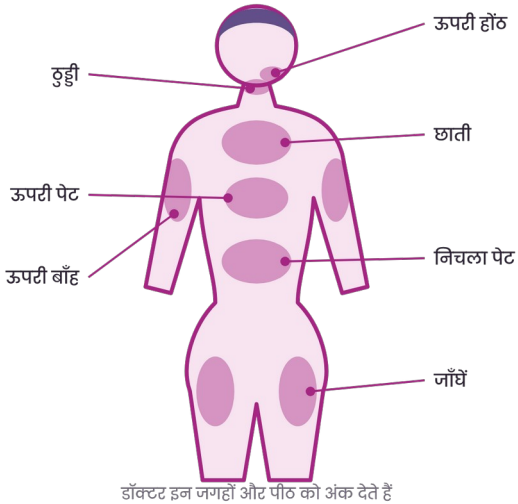
अगर कई महीने पीरियड न आए, तो गर्भाशय की परत मोटी होती रह सकती है। सालों में इससे भारी ब्लीडिंग और कभी-कभी परत में गंभीर बदलाव हो सकते हैं। डॉक्टर इसे बचाने का सरल इलाज दे सकते हैं।

किशोरियों के लिए

15 साल तक पीरियड न आए, या स्तन विकास शुरू होने के 3 साल बाद भी न आए, तो डॉक्टर को दिखाएँ।

बाल, मुँहासे और बाल झड़ना

एंड्रोजन कुछ बालों की जड़ों को मोटे, गहरे बाल उगाने पर मजबूर करते हैं और तेल ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं। सिर की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं।



डॉक्टर इन जगहों और पीठ को अंक देते हैं

ज़्यादा बाल

हर्सुटिज़्म

ऊपरी होंठ, ठुड्डी, छाती, पेट, पीठ या जाँघों पर मोटे, गहरे बाल। यह ज़्यादातर महिलाओं के हल्के, महीन रोओं से अलग है।

मुँहासे

जबड़े, ठुड्डी और निचले चेहरे पर दर्दभरे दाने। पीरियड से पहले बढ़ते हैं और दाग छोड़ सकते हैं।

बाल झड़ना

माँग चौड़ी होती है और ऊपर से बाल पतले लगते हैं। आगे की हेयरलाइन आमतौर पर बनी रहती है।

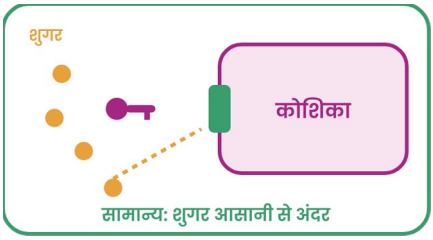
क्या मदद करता है

- इलाज का असर **3 से 6 महीने** में दिखता है। बाल धीरे बढ़ते हैं।
- दवाएँ **नए** बाल और मुँहासे घटाती हैं। लेज़र या इलेक्ट्रोलिसिस मौजूदा बाल हटाते हैं।
- शेविंग या थ्रेडिंग से बाल मोटे **नहीं** होते।
- **आयरन, थायरॉइड और विटामिन D** भी जाँचें। इनकी कमी से भी बाल झड़ते हैं।

इंसुलिन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम

इंसुलिन रेज़िस्टेंस

इंसुलिन एक **चाबी** है जो शुगर को कोशिकाओं में जाने देती है। जब ताला कड़ा हो जाए, तो शरीर **और चाबियाँ** बनाता है। ज़्यादा इंसुलिन अंडाशय को ज़्यादा एंड्रोजन बनाने को कहता है।





संकेत: गर्दन के गहरे दाग, स्किन टैग, मीठे की चाहत, पेट की चर्बी, खाने के बाद नींद। **दुबली महिलाओं को भी हो सकता है।**

मेटाबॉलिक सिंड्रोम

यानी इन 5 में से **3 या ज़्यादा** मौजूद हैं। इससे डायबिटीज़ और हृदय रोग का जोखिम बढ़ता है।

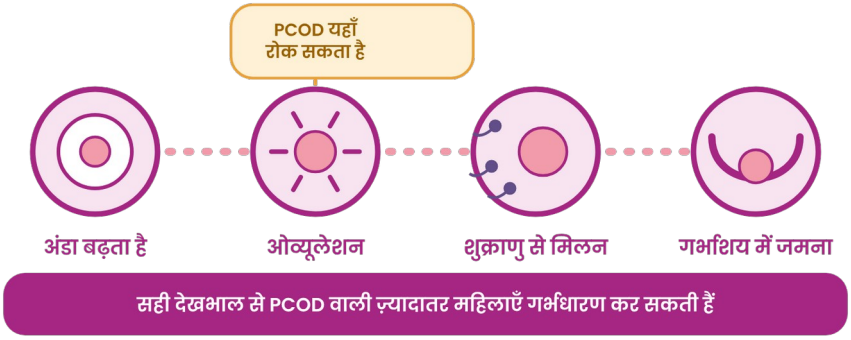
कमर	ब्लड प्रेशर	फास्टिंग शुगर	ट्राइग्लिसराइड	HDL (अच्छा) कोलेस्ट्रॉल
80 सेमी या ज़्यादा	130/85 या ज़्यादा	100 mg/dL या ज़्यादा	150 mg/dL या ज़्यादा	50 mg/dL से कम

5 में से 3 = मेटाबॉलिक सिंड्रोम

> जाँच के लिए एक साधारण ब्लड टेस्ट और इंच टेप काफ़ी है। जल्दी कदम उठाने से इसे पलटा जा सकता है।

PCOD और गर्भधारण

PCOD **ओव्यूलेशन की समस्याओं** का सबसे आम कारण है। इसका मतलब यह **नहीं** कि आप माँ नहीं बन सकतीं। PCOD वाली ज़्यादातर महिलाएँ गर्भधारण करती हैं, कभी-कभी चिकित्सा मदद से।



देर क्यों लग सकती है

- अंडा नियमित रूप से परिपक्व या मुक्त नहीं हो पाता।
- ज़्यादा इंसुलिन और एंड्रोजन चक्र बिगाड़ते हैं।
- अन्य कारण (नलियाँ, गर्भाशय, पति के शुक्राणु) साथ में जाँचे जाते हैं।

मदद कब लें

- **12 महीने** कोशिश के बाद (35 साल से कम)।
- **6 महीने** कोशिश के बाद (35 साल या ज़्यादा)।
- पीरियड्स बहुत अनियमित या बंद हों तो **जल्दी**।

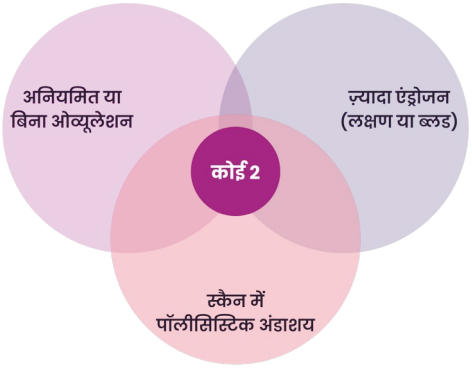
गर्भावस्था से पहले और दौरान

सलाह अनुसार **फोलिक एसिड** शुरू करें, सही वज़न रखें, धूम्रपान और शराब छोड़ें। PCOD में **गर्भावधि डायबिटीज़ और हाई BP** की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए शुरू से जाँच ज़रूरी है।

निदान

PCOD की जाँच कैसे होती है

कोई एक टेस्ट नहीं है। डॉक्टर **रॉटरडैम मापदंड** इस्तेमाल करते हैं: अन्य बीमारियाँ हटाने के बाद इन 3 में से **कोई 2** संकेत।



जो जाँचें सुझाई जा सकती हैं

हार्मोन	LH-FSH, AMH, प्रोलैक्टिन, TSH, फ्री टेस्टोस्टेरोन, SHBG, DHEA-S	**शुगर**	HbA1c, फास्टिंग शुगर और इंसुलिन, OGTT, HOMA-IR
हृदय	लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, hs-CRP, ज़रूरत पर ECG या ECHO	**विटामिन**	विटामिन D, B12, आयरन, लिवर टेस्ट
स्कैन	अंडाशय और गर्भाशय की परत का पेल्विक अल्ट्रासाउंड	**शरीर**	वज़न, कमर, बॉडी कंपोज़िशन, त्वचा और बालों का विश्लेषण

किशोरियाँ: पीरियड शुरू होने के पहले 8 साल में सिर्फ़ स्कैन से PCOD का निदान नहीं किया जाता।

लक्षण डिकोडर

इसका मतलब क्या है?

आप क्या देखती हैं	इसका मतलब हो सकता है	क्या करें
35 दिन से ज़्यादा के अंतर पर या छूटे पीरियड	नियमित ओव्यूलेशन नहीं हो रहा	**तारीख़ लिखें, डॉक्टर से मिलें**
बहुत भारी पीरियड, थक्के	मोटी परत, फाइब्रॉइड या थायरॉइड	**जल्दी डॉक्टर से मिलें**
जबड़े और ठुड्डी पर मुँहासे	ज़्यादा एंड्रोजन	**हार्मोन और त्वचा जाँच**
ठुड्डी या छाती पर नए गहरे बाल	ज़्यादा एंड्रोजन	**हार्मोन टेस्ट**
माँग पर बाल पतले	एंड्रोजन, कम आयरन, थायरॉइड	**ब्लड टेस्ट**
गर्दन पर मखमली गहरे दाग	इंसुलिन रेज़िस्टेंस	**शुगर और इंसुलिन टेस्ट**
पेट पर वज़न, मीठे की चाहत	इंसुलिन रेज़िस्टेंस	**डाइट और गतिविधि योजना**
थकान, खर्राटे, कम नींद	स्लीप एपनिया, थायरॉइड, एनीमिया	**डॉक्टर जाँच**
उदासी, लगातार चिंता	PCOD में आम	**किसी से बात करें, काउंसलिंग**
6 से 12 महीने में गर्भ नहीं	ओव्यूलेशन की समस्या	**फर्टिलिटी परामर्श**

तुरंत मदद लें अगर

पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द, बेहोशी, बहुत भारी ब्लीडिंग, सीने में दर्द या साँस फूलना, या **अचानक** आवाज़ भारी होना और बाल तेज़ी से बढ़ना।

जीवनशैली

PCOD में सही खान-पान

कोई एक "PCOD डाइट" नहीं होती। लक्ष्य है शुगर स्थिर रखना और सूजन घटाना। दोपहर और रात के खाने में नीचे दी थाली अपनाएँ। कदम-दर-कदम रोडमैप अगले पेज पर है।



- **1/2** सब्ज़ियाँ और सलाद
- **1/4** प्रोटीन — दाल, पनीर, अंडा, दही
- **1/4** साबुत अनाज — मिलेट रोटी
- अच्छी वसा: एक चम्मच तेल, मेवे
- 2-3 L

ज़्यादा खाएँ

- मिलेट: ज्वार, बाजरा, रागी
- दालें, अंकुरित अनाज, चना, राजमा
- सब्ज़ियाँ और सलाद
- दही, पनीर, अंडा, मछली
- मेवे, बीज, बेरीज़, अमरूद

कम खाएँ

- मैदा, बिस्किट, सफ़ेद ब्रेड
- चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, मिठास वाले पदार्थ
- पैकेट वाले और तले स्नैक्स
- सफ़ेद चावल की बड़ी मात्रा
- रात को देर से भारी खाना

छोटी आदतें जो मदद करती हैं

- हर भोजन में प्रोटीन, खासकर नाश्ते में।
- पहले सब्ज़ियाँ, फिर प्रोटीन, कार्ब सबसे अंत में खाएँ।
- क्रैश डाइट से बचें। ये उलटा असर करती हैं।

आपका 5-चरण का आहार रोडमैप

इंसुलिन रेज़िस्टेंस, सूजन, ज़्यादा एंड्रोजन और आँतों की सेहत पर केंद्रित, कदम-दर-कदम योजना। यहाँ "डिटॉक्स" का मतलब जूस क्लीनज़ या भूखा रहना **नहीं** है, बल्कि रिफ़ाइंड चीनी और प्रोसेस्ड खाना घटाना और लिवर व आँतों की मदद करने वाले साबुत खाद्य खाना है।



चरण	आप क्या करें	रात अंतराल
चरण 1 हफ़्ते 1-2	**रीसेट.** रिफ़ाइंड चीनी, मिठास वाले पदार्थ, पैकेट का खाना, ज़्यादा बीज वाले तेल हटाएँ। डेयरी/ग्लूटेन तभी, जब वे परेशान करें। ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी जोड़ें। रोज़ 30 ग्राम फाइबर; प्रोटीन, कार्ब, वसा लगभग बराबर।	9-10 घंटे
चरण 2 हफ़्ते 3-6	**सूजन घटाएँ.** भूमध्यसागरीय शैली: जैतून का तेल, हफ़्ते में 2-3 बार फैटी फिश (शाकाहारी: अलसी या स्पिरुलिना), बेरीज़, काली मिर्च के साथ हल्दी, दालचीनी। प्रोटीन 25-30%, कार्ब 35-40%, वसा 35%। सलाह पर HBOT।	11-12 घंटे
चरण 3 हफ़्ते 7-12	**आँतों की सेहत.** 35 ग्राम या ज़्यादा फाइबर: दालें, चना, चिया, अलसी, कद्दू के बीज, ठंडा किया आलू। आँत-हितैषी ड्रिंक। वैकल्पिक सीड साइक्लिंग। तीसरे महीने के अंत में समीक्षा।	11-12 घंटे
चरण 4 महीने 4-5	**सुधार.** पहले सब्ज़ियाँ, फिर प्रोटीन और वसा, कार्ब सबसे अंत में। देर रात न खाएँ। प्राचीन अनाज जोड़ें: क्विनोआ, खपली गेहूँ, कुट्टू।	12-14 घंटे
चरण 5 महीना 6	**निरंतरता.** 80/20 नियम: 80% सूजन-रोधी, 20% लचीलापन। खाद्य पदार्थ एक-एक करके दोबारा शुरू कर सहनशीलता जाँचें। हर भोजन में 25-30 ग्राम प्रोटीन।	-

सीड साइक्लिंग (वैकल्पिक): दिन 1-14: रोज़ 1 चम्मच कद्दू के बीज + 1 चम्मच पिसी अलसी। दिन 15-28: रोज़ 1 चम्मच तिल + 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज। प्रमाण सीमित हैं, इसलिए यह वैकल्पिक है।

जीवनशैली

चलें, सोएँ, शांत रहें

चलने-फिरने से कोशिकाएँ फिर से इंसुलिन की सुनने लगती हैं। अच्छी नींद और शांति भूख और तनाव के हार्मोन संतुलित करती हैं।

सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि
🚶‍♀️	🏋️‍♀️	🧘‍♀️	🚶‍♀️	🏋️‍♀️	💃	😴
वॉक	स्ट्रेंथ	योग	वॉक	स्ट्रेंथ	डांस	आराम

🚶‍♀️ हर दिन खाने के बाद 10 मिनट की सैर

चलें

हफ़्ते में **150 मिनट** तेज़ चलना, साइकिल, तैराकी या डांस, और **2 दिन स्ट्रेंथ** एक्सरसाइज़। 10 मिनट भी गिने जाते हैं।

सोएँ

रोज़ एक समय पर **7 से 9 घंटे**। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। अँधेरा, ठंडा कमरा।

शांत रहें

रोज़ 10 मिनट **योग, प्राणायाम या ध्यान**। शौक और दोस्तों के लिए समय।

छोटी शुरुआत करें। इस हफ़्ते एक आदत चुनें। निभ सकने वाले छोटे कदम, छूट जाने वाली बड़ी योजनाओं से बेहतर हैं।

इस हफ़्ते मैं करूँगी:

1.

2.

3.

इलाज के विकल्प

इलाज इस पर निर्भर है कि **आप क्या चाहती हैं**: नियमित पीरियड्स, साफ़ त्वचा, कम बाल, या बच्चा। आपके डॉक्टर आपकी योजना बनाएँगे। पेज 19 और 20 में हर लक्षण का इलाज दिया है।



- **नियमित पीरियड्स, गर्भाशय की सुरक्षा:** पीरियड नियमित करने और एंड्रोजन घटाने के लिए हार्मोनल गोलियाँ या प्रोजेस्टिन
- **इंसुलिन रेज़िस्टेंस, वज़न:** पोषण योजना, गतिविधि, सलाह अनुसार मेटफॉर्मिन और अन्य दवाएँ
- **मुँहासे, ज़्यादा बाल, बाल झड़ना:** एंटी-एंड्रोजन दवाएँ, त्वचा उपचार, लेज़र

अगर लक्ष्य गर्भधारण है

ओव्यूलेशन की दवाएँ	चक्र की शुरुआत में गोलियाँ या इंजेक्शन अंडे को बढ़ने और निकलने में मदद करते हैं। अक्सर पहला कदम। स्कैन से वृद्धि देखी जाती है।
IUI	ओव्यूलेशन के समय तैयार किए गए शुक्राणु गर्भाशय में रखे जाते हैं।
IVF / ICSI	अंडे निकालकर लैब में निषेचित किए जाते हैं और भ्रूण गर्भाशय में रखा जाता है। पहले के कदम विफल हों या अन्य कारण हों तब।
LOD	अंडाशय की छोटी की-होल सर्जरी, जब दूसरे कदम काम न करें तब कभी-कभी इस्तेमाल।

> **ज़रूरी:** दवाएँ और सप्लीमेंट (इनोसिटोल, विटामिन D सहित) सिर्फ़ डॉक्टर की सलाह पर लें।

हर लक्षण का इलाज कैसे करते हैं

हर लक्षण की अपनी जाँचें और विकल्प हैं। आपके डॉक्टर सिर्फ़ वही चुनते हैं जो **आपके** लिए उपयुक्त है।

अनियमित या दर्दभरे पीरियड, पीरियड बंद होना, गर्भधारण में कठिनाई

जाँचें	पेल्विक अल्ट्रासाउंड, LH-FSH, AMH, प्रोलैक्टिन, TSH
चिकित्सा	हार्मोनल गोलियाँ, ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाएँ
पोषण	लक्षित डाइट, इनोसिटोल (मायो और D-काइरो), CoQ10
उन्नत	HBOT, पेल्विक चेयर
आयुर्वेद	शतावरी, अश्वगंधा, कांचनार गुग्गुलु; औषधीय एनिमा, उत्तर बस्ति, योनि प्रक्षालन

मुँहासे, ज़्यादा बाल, बाल झड़ना

जाँचें	फ्री टेस्टोस्टेरोन, SHBG, FAI, DHEA-S, एंड्रोस्टेनेडियोन; त्वचा और बालों का विश्लेषण
चिकित्सा	एंटी-एंड्रोजन दवाएँ, रेटिनॉयड
पोषण	लक्षित डाइट, NAC, करक्यूमिन, ज़िंक
उन्नत	लेज़र हेयर रिडक्शन, क्यू-स्विच लेज़र, केमिकल पील, हाइड्रा और औषधीय फेशियल, माइक्रोनीडलिंग, PRP, एक्सोसोम, ओज़ोन
आयुर्वेद	रक्तशोधन, रक्तमोक्षण, विरेचन, मुखलेप; नस्य, अभ्यंग, शिरो पिचु

> उन्नत और आयुर्वेदिक विकल्प **सहायक** हैं और डॉक्टर की सलाह पर ही दिए जाते हैं। ये चिकित्सा देखभाल की जगह नहीं लेते।

हर लक्षण का इलाज (2)

वज़न बढ़ना, भूख और इंसुलिन रेज़िस्टेंस (हृदय स्वास्थ्य भी)

जाँचें	फास्टिंग शुगर और इंसुलिन, HbA1c, OGTT, HOMA-IR, लिपिड प्रोफाइल, hs-CRP, बॉडी कंपोज़िशन जाँच, ECG और ECHO
चिकित्सा	मेटफॉर्मिन; नई वज़न घटाने वाली दवाएँ (GLP-1 प्रकार) या ऑर्लिस्टैट, केवल डॉक्टर की सलाह पर
पोषण	लो-GI, सूजन-रोधी या भूमध्यसागरीय योजना; रोज़ की ज़रूरत से लगभग 500 कैलोरी कम; आँत-हितैषी ड्रिंक; बर्बेरिन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, विटामिन (सलाह पर)
उन्नत	बॉडी कंटूरिंग (क्रायोलिपोलिसिस, RF, मसल स्टिमुलेशन, माइक्रोवेव), HBOT, ओज़ोन
आयुर्वेद	त्रिफला, त्रिकटु, अर्जुन, गुग्गुलु; उद्वर्तन, स्वेदन, वमन

थकान, नींद और मूड

जाँचें	कोर्टिसोल कर्व, B12, फोलेट, फेरिटिन और आयरन, विटामिन D3, स्लीप एपनिया जाँच, लिवर टेस्ट
चिकित्सा	नींद और मूड का मूल्यांकन, काउंसलिंग और CBT, उपयुक्त होने पर हार्मोनल दवाएँ या स्पाइरोनोलैक्टोन, स्लीप एपनिया के लिए CPAP
पोषण	विटामिन D, ओमेगा-3, नींद में सहायक आहार
आयुर्वेद	ब्राह्मी, जटामांसी; शिरोधारा, अभ्यंग

गर्भाशय की परत की सुरक्षा

जाँचें	परत की मोटाई के लिए अल्ट्रासाउंड, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, हिस्टेरोस्कोपी; CA-125 और MRI सिर्फ़ ज़रूरत पर
चिकित्सा	चक्रीय प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टिन वाली IUD, हार्मोनल गोलियाँ
पोषण	इनोसिटोल, करक्यूमिन, क्रूसिफेरस सब्ज़ियाँ
उन्नत	पेल्विक चेयर, एक्यूपंक्चर, पंचकर्म
आयुर्वेद	अशोक, शतावरी

कोई भी दवा, सप्लीमेंट या थेरेपी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें।

मन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य

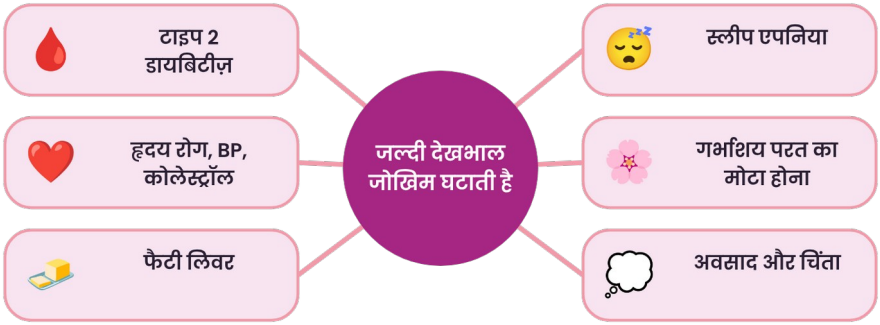
आपकी भावनाएँ असली हैं

PCOD में चिंता, उदासी और शारीरिक छवि की फ़िक्र **2 से 3 गुना ज़्यादा** आम है। यह कमज़ोरी नहीं है। हार्मोन और इंसुलिन की भूमिका होती है। बात करने से मदद मिलती है। काउंसलिंग के बारे में हमसे पूछें।

मदद कब माँगें

दो हफ़्ते से ज़्यादा चलने वाली उदासी या चिंता, घबराहट के दौरे, रोज़मर्रा की चीज़ों में रुचि खत्म होना, या नींद और भूख में गड़बड़ी। अगर कभी खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आएँ, तो तुरंत किसी को बताएँ और मदद लें। निःशुल्क हेल्पलाइन: **टेली-मानस 14416** (24x7)।

संभावित दीर्घकालिक जोखिम

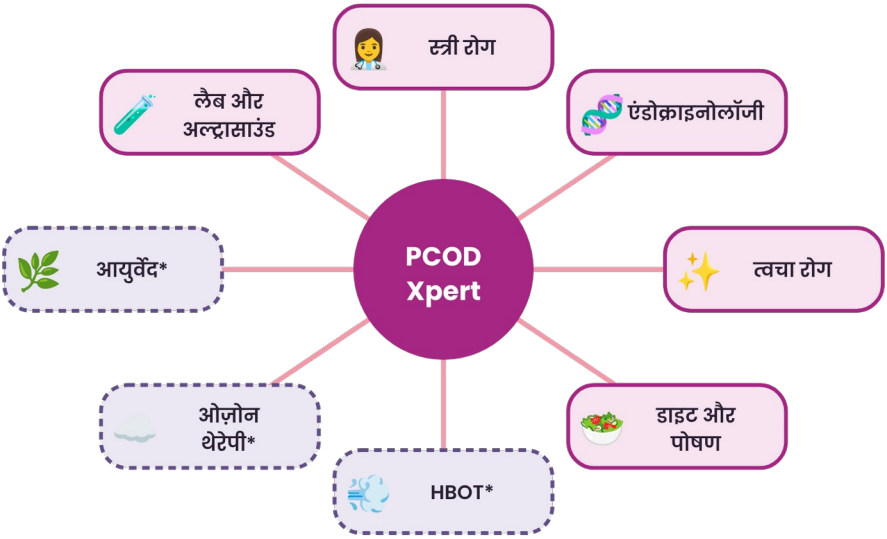


खुद को सुरक्षित रखें

- **हर साल ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल** जाँचें।
- **कम से कम हर 3 महीने में एक पीरियड** का लक्ष्य रखें।
- सक्रिय रहें, अच्छा खाएँ, अच्छा सोएँ।
- जल्दी देखभाल से ये जोखिम बहुत घटते हैं।

सब कुछ एक ही छत के नीचे

PCOD शरीर के कई हिस्सों को छूता है, इसलिए अक्सर एक डॉक्टर काफ़ी नहीं होता। PCOD Xpert में एक **बहु-विशेषज्ञ टीम** परामर्श से लेकर जाँचों तक, एक ही कैंपस में आपकी योजना पर साथ काम करती है।



*सहायक, डॉक्टर की सलाह अनुसार

एक छत के नीचे क्यों बेहतर है

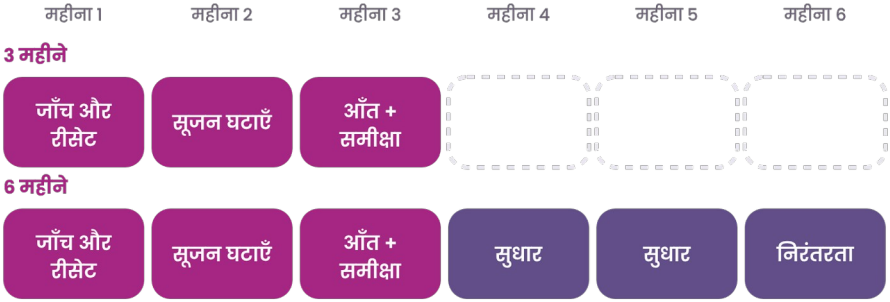
- **एक योजना** जिस पर सभी विशेषज्ञ साथ काम करते हैं।
- **जाँचें और स्कैन** उसी कैंपस में।
- **कम चक्कर**, साफ़ फ़ॉलो-अप और एक टीम जिसे कॉल कर सकें।

सहायक थेरेपी

HBOT, ओज़ोन थेरेपी और आयुर्वेद सिर्फ़ आपके डॉक्टर की सलाह पर **अतिरिक्त सहायक विकल्प** के रूप में दी जाती हैं। PCOS में HBOT और ओज़ोन की भूमिका पर शोध अभी जारी है। ये जीवनशैली, दवाओं या फर्टिलिटी देखभाल की जगह नहीं लेतीं।

3 और 6 महीने के प्रोग्राम

5-चरण आहार रोडमैप पर आधारित, नियमित समीक्षा के साथ एक व्यवस्थित सफ़र, ताकि आप PCOD को अकेले न संभालें।



3 महीने का प्रोग्राम

महीना 1	**जाँच और रीसेट** स्त्री रोग, एंडोक्राइन, त्वचा और डाइट परामर्श। ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। आहार के चरण 1 और 2 शुरू।
महीना 2	**सूजन घटाएँ** भूमध्यसागरीय शैली का आहार। ज़रूरत अनुसार दवाएँ और त्वचा/बालों की देखभाल। सलाह पर सहायक थेरेपी। फ़ॉलो-अप।
महीना 3	**आँतों की सेहत और समीक्षा** ज़्यादा फाइबर वाला, आँत-हितैषी आहार (चरण 3)। माप और जाँचें दोहराना। प्रगति की जाँच और आगे की योजना।

6 महीने का प्रोग्राम

3 महीने के प्रोग्राम की सब बातें, और **महीना 4 से 6**: उन्नत खान-पान की आदतें (चरण 4), लचीली दीर्घकालिक दिनचर्या (चरण 5), मासिक चेक-इन, दवाओं में सुधार, चाहें तो फर्टिलिटी योजना, और आपकी जाँचों व दीर्घकालिक स्वास्थ्य योजना की पूरी समीक्षा।

आपकी ज़रूरत के अनुसार हर प्रोग्राम में क्या शामिल है, हमारी टीम से पूछें।

मिथक और तथ्य

मिथक	तथ्य
PCOD का मतलब मैं कभी माँ नहीं बन सकती।	PCOD वाली ज़्यादातर महिलाएँ गर्भधारण करती हैं, कभी-कभी इलाज से।
PCOD सिर्फ़ मोटी महिलाओं को होता है।	दुबली महिलाओं को भी PCOD और इंसुलिन रेज़िस्टेंस हो सकता है।
PCOD जंक फ़ूड से होता है।	पहले जीन और हार्मोन आते हैं। जीवनशैली इसे काबू में रखने में मदद करती है।
नियमित पीरियड्स यानी PCOD नहीं।	नियमित पीरियड्स में भी PCOD हो सकता है। जाँच से पता चलता है।
शेविंग से बाल मोटे उगते हैं।	ऐसा नहीं है। दोबारा उगते बाल सिर्फ़ खुरदुरे लगते हैं।
चावल और घी हमेशा के लिए छोड़ने होंगे।	मात्रा और संतुलन मायने रखते हैं। क्रैश डाइट काम नहीं करती।
शादी या बच्चे के बाद PCOD ठीक हो जाता है।	कुछ समय राहत हो सकती है, पर लगातार देखभाल चाहिए।
गोलियाँ ही इकलौता इलाज हैं।	जीवनशैली आधार है। दवाएँ आपके लक्ष्य के अनुसार चुनी जाती हैं।

सवाल और जवाब

क्या PCOD आनुवंशिक है?

अक्सर परिवारों में चलता है, पर रिश्तेदार को PCOD होने का मतलब यह नहीं कि आपको ज़रूर होगा।

क्या दवाएँ हमेशा लेनी होंगी?

हमेशा नहीं। कई महिलाएँ जीवनशैली से सुधरती हैं और दवाएँ सिर्फ़ कुछ लक्ष्यों या कुछ समय के लिए लगती हैं।

क्या PCOD से कैंसर हो सकता है?

अगर सालों तक पीरियड बहुत कम आएँ, तो गर्भाशय की परत ज़्यादा बढ़ सकती है। जल्दी इलाज से आप सुरक्षित रहती हैं।

PCOS का नाम PMOS क्यों रखा गया?

PMOS बताता है कि यह स्थिति सिर्फ़ अंडाशय को नहीं, पूरे शरीर के हार्मोन और मेटाबॉलिज़्म को प्रभावित करती है। आपके डॉक्टर दोनों नाम इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या बिना इलाज के गर्भधारण हो सकता है?

PCOD में कुछ महिलाओं में कभी-कभी ओव्यूलेशन होता है और वे स्वाभाविक रूप से गर्भवती हो जाती हैं। 6 से 12 महीने में न हो तो मदद लें।

क्या तनाव से PCOD बिगड़ता है?

हाँ। तनाव के हार्मोन इंसुलिन और ओव्यूलेशन को प्रभावित करते हैं। नींद, व्यायाम और किसी से बात करना मदद करते हैं।

डॉक्टर से पूछने के सवाल

- [ ] मुझे किस तरह का PCOD है?
- [ ] कौन सी जाँचें, और कितनी बार?
- [ ] अगले 3 महीनों के लिए मेरे लक्ष्य क्या हैं?
- [ ] कौन सी दवाएँ, और कितने समय तक?
- [ ] गर्भधारण की योजना कब बनाऊँ?

मेरा ट्रैकर

हर पीरियड का **पहला दिन** लिखें। अपॉइंटमेंट पर यह पेज साथ लाएँ।

पीरियड शुरू	दिन	फ़्लो कम/मध्यम/ज़्यादा	दर्द 0–10	वज़न	नोट्स

मेरी दवाएँ और सप्लीमेंट:

अगला अपॉइंटमेंट:

मरीज़ों की कहानियाँ

उम्मीद भीतर से खिलती है

उन महिलाओं की सच्ची कहानियाँ जिन्होंने पहला कदम उठाया।

फ़ोटो

"

यहाँ मरीज़ के अपने शब्द जोड़ें (लिखित सहमति के साथ)।

मरीज़ का नाम, उम्र
PCOD के साथ वर्ष / PCOD Xpert के साथ महीने

फ़ोटो

"

यहाँ मरीज़ के अपने शब्द जोड़ें (लिखित सहमति के साथ)।

मरीज़ का नाम, उम्र
PCOD के साथ वर्ष / PCOD Xpert के साथ महीने

PCOD Xpert

Hope Blooms from Within

PCOD को नज़रअंदाज़ न करें।

हमसे जुड़ें।

कॉल या WhatsApp करें

+91 82230 87999

WhatsApp | कॉल

WhatsApp पर चैट के लिए स्कैन करें

PCOD, PCOS और PMOS की देखभाल, एक ही छत के नीचे

स्त्री रोग | एंडोक्राइनोलॉजी | त्वचा रोग | डाइट और पोषण | आयुर्वेद | लैब और अल्ट्रासाउंड

हमसे मिलें

सहज हॉस्पिटल कैंपस

15/2 साउथ तुकोगंज, मानस भवन के पास,
होटल सूर्या के पीछे, इंदौर,
मध्य प्रदेश 452005

चिकित्सकीय अस्वीकरण

यह पुस्तिका केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। परिणाम हर व्यक्ति में अलग होते हैं। कोई भी इलाज शुरू या बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। प्रोग्राम का विवरण आपके उपचारकर्ता डॉक्टर तय करते हैं। उन्नत और आयुर्वेदिक थेरेपी सहायक हैं और केवल सलाह पर दी जाती हैं।